

Medicina 2026.2

Planos de ENSINO

1º Período - 2º/2026

UNIEURO
CENTRO UNIVERSITÁRIO

INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE-GESTÃO I

1. IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Bacharelado em Medicina.		
UNIDADE CURRICULAR: IESCG I		
CÓDIGO DA TURMA: MED 01I2	**PERÍODO:** 1º período	
SEMESTRE LETIVO: 2026.2	**CARGA HORÁRIA SEMANAL:** 4h	**CARGA HORÁRIA TOTAL:** 80h

2. EMENTA: SUS E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- História das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Reforma Sanitária Brasileira.
- Princípios e Diretrizes do SUS.
- Equidade e Políticas Públicas: atenção à saúde da população do campo florestas e águas; saúde indígena, saúde da população negra, saúde da população com deficiência; saúde do trabalhador.
- História da APS no Brasil. Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família.
- Visita Domiciliar e o Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
- Desigualdades em Saúde.
- Pessoas em vulnerabilidade social e meio ambiente.
- Promoção da saúde.
- Educação em Saúde: Continuada, Permanente e Popular.
- Metodologias de Trabalho de Extensão.

Extensão Comunitária: Projeto de Intervenção com ênfase em Promoção da Saúde e Educação.

3. PERFIL DO EGRESSO

I. Propositivo, com formação generalista e sólida formação científica e tecnológica para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, pautando a tomada de decisões pela análise crítica e contextualizada.

II. Ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais, considerando as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais espectro da diversidade humana multicultural.

III. Sensível à singularidade de cada pessoa ou grupo social, tratando as desigualdades com equidade e visando a integralidade e humanização do cuidado em saúde, sem preconceitos de qualquer espécie.

IV. Proativo, flexível, criativo e com atuação inovadora para identificar, avaliar e propor condutas terapêuticas adequadas, suprindo as demandas individuais e coletivas e valorizando a diversidade multicultural.

V. Sistemático em relação às atividades do seu fazer profissional, visando a racionalização e otimização do uso dos recursos disponíveis, orientado pelos princípios de efetividade e eficiência.

VI. Crítico e reflexivo em relação ao seu fazer profissional, orientado pelas melhores evidências científicas disponíveis e pelos princípios de custo-efetividade e eficácia, contribuindo para construção de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde.

VII. Protagonista do saber, com visão do mundo em sua diversidade e prática médica contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como agentes ativos de sua própria saúde.

VIII. Colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes, atuando com respeito, cooperação e iniciativa, exercendo a liderança na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões e comunicar-se pela interação, participação e diálogo.

IX. Respeitoso, empático e ético na relação médico-paciente, no trato com os usuários dos serviços de saúde, seus familiares e comunidade, bem como com os demais membros das equipes profissionais envolvidas;

X. Responsável social e ambientalmente, defensor da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano, de modo que, no desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser humano, ambiente, sociedade e tecnologias, e contribua para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas de saúde;

XI. Comprometido com a sua educação permanente e com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde, priorizando a autonomia intelectual.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Sala de Aula Invertida
- Role Play – Dramatização
- Ensino Baseado em Projetos de Extensão Comunitária;
- Mentoring-like no acompanhamento longitudinal dos estudantes (profissional de campo).

5. ATIVIDADES

1. Atividades de Campo sob supervisão de profissional de saúde extensionista (Unidades Básicas de Saúde e Território) onde se espera que o estudante no mínimo realize:

a) 01 (uma) visita geral na UBS para compreensão do funcionamento do serviço da APS, e reflexão à luz do conceito de Equipe Multidisciplinar e Acolhimento.

b) 01 (um) cadastramento via sistema (e-SUS APS).

c) 01 (uma) visita domiciliar acompanhado do ACS, Enfermeiro ou Médico.

d) 01 (uma) observação do atendimento clínico e do processo de trabalho de profissionais da UBS.

- ✓ **As atividades devem ser registradas em diários de campo (RADE).**

2. **Projeto de Intervenção Coletivo** (PIC) – utilizando metodologias do Ensino Baseado na Comunidade (EBC), a partir de um problema local trazido pelas equipes de saúde da UBS, e que tenha conexão com os objetivos de aprendizagem do semestre, os estudantes deverão realizar atividade para alcançar metas relacionadas ao problema, com objetivos definidos e passos a serem realizados, dentro de metodologia de Ensino Baseado em Projetos. Haverá suporte para o desenvolvimento dessa atividade vindo das áreas de Iniciação Científica e Humanidades Médicas; e o acompanhamento será realizado pelo profissional de saúde extensionista que acompanhará o campo.

- O estudante deverá cumprir integralmente a carga horária de atividades práticas, para conclusão da unidade curricular.
- As REPOSIÇÕES somente serão aceitas após o estudante abrir um requerimento exclusivamente por meio do Portal do Aluno, dentro do prazo previsto de 72h, solicitando a reposição referente ao dia em que esteve de atestado médico ou de acompanhamento, devendo informar no requerimento: *o IESCG em curso (IESCG I) a UBS da prática (Ex: UBS 1 Samambaia), o (s) dia (s) referente a falta e obrigatoriamente anexar o atestado para comprovar sua ausência*, e após deferimento pela coordenação de estágio, o estudante deverá agendar com o seu preceptor a reposição com prazo máximo de 2 semanas, que só poderá acontecer nas quartas, quintas ou sextas a tarde, das 13:30h às 17:30h.
- O preceptor, que apoia as atividades de campo do estudante, cumprirá um papel de referência inspirador (mentoria-like), no sentido de proporcionar feedbacks, orientações, conselhos, suporte e acompanhamento individual de cada estudante.

6. AVALIAÇÃO

A nota final (N) da unidade curricular será composta por:

$$\textbf{Nota Final (N)} = \frac{\textbf{N1 + N2}}{\textbf{2}}$$

I. A **N1** será composta pela avaliação somativa 1 (AS 1) que corresponderá a 60% da nota e pela avaliação formativa 1 (AF 1) que corresponderá a 40% da nota, referente ao 1º bimestre.

- A **avaliação somativa** 1 (AS) será realizada por meio da aplicação de uma avaliação com questões objetivas de múltipla escolha e outra por questões discursivas, contemplando situações contextualizadas que favoreçam a avaliação crítica e reflexiva do processo de ensino-aprendizagem nas aulas teóricas/práticas.
- A **avaliação formativa** 1 (AF) será relacionada às atividades propostas em sala de aula

➢ Cada nota terá o valor entre 0 e 10, com os seguintes pesos distribuídos: **N1:** AS 1 (6,0) + AF (4,0).

II. A **N2** será composta pelo PIC com 50% da nota, pelo Portfólio Reflexivo e Descritivo com 40% da nota, e pela avaliação formativa (AF2) realizada pelos preceptores de campo, que corresponderá a 10% da nota, referente ao 2º bimestre.

➢ Cada nota terá o valor entre 0 e 10, com os seguintes pesos distribuídos: **N2: PIC** (5,0 – **1,5** nota coletiva referente a escrita e entrega do trabalho; **1,5** apresentação individual e coletiva em sala de aula; **2,0** nota individual na produção do relato de experiência) **+ Portfólios** (4,0) **+ Avaliação Formativa 2** (1,0).

III. Segunda chamada das avaliações bimestrais (N1) – o discente que deixar de comparecer à primeira avaliação bimestral (N1) poderá requerer a realização da prova em segunda chamada, desde que apresente justificativa devidamente comprovada, observados os critérios estabelecidos na Resolução CONSU nº 23/26. A nota obtida na segunda chamada das avaliações bimestrais substituirá integralmente a nota da avaliação bimestral correspondente para todos os efeitos acadêmico. Não haverá arredondamento da nota obtida na segunda chamada das avaliações bimestrais.

- **Não haverá segunda chamada das avaliações bimestrais (N2) para disciplinas cuja avaliação seja realizada exclusivamente por provas práticas.**

- Será considerado aprovado, desde que atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e 100% das práticas, o discente que:

  I – obtiver Média Parcial (MP) igual ou superior a 6,0 (seis), correspondente à média aritmética simples das notas das avaliações bimestrais (N1 e N2), não havendo arredondamento;

  II – obtiver Média Parcial (MP) inferior a 6,0 (seis), hipótese em que poderá realizar a Avaliação de Recuperação da Aprendizagem (ARA);

  III – obtiver Média Final (MF) igual ou superior a 6,0 (seis), após a realização da Avaliação de Recuperação da Aprendizagem (ARA), calculada pela seguinte fórmula: MF = (MP + ARA) ÷ 2

IV. Avaliação de Recuperação da Aprendizagem (ARA) - abrangerá todo o conteúdo programático desenvolvido na disciplina durante o semestre letivo. A nota obtida na ARA não substituirá as notas das avaliações bimestrais, destinando-se exclusivamente ao cálculo da Média Final (MF). O critério institucional de arredondamento será aplicado exclusivamente à Média Final (MF) obtida após a realização da Avaliação de Recuperação da Aprendizagem (ARA), considerando-se aprovado o discente cuja Média Final seja igual ou superior a 5,75 (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos), hipótese em que será registrada a nota final 6,0 (seis).

- A Avaliação de Recuperação da Aprendizagem (ARA) **não se aplica às disciplinas avaliadas exclusivamente por práticas**, sendo considerado reprovado o discente que deixar de cumprir carga horária total de prática, conforme regulamento próprio.

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

1. GUSSO, Gustavo; LOPES, José M C.; DIAS, Lêda C. Tratado de medicina de família e comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715369/. Acesso em: 01 jul. 2024.
2. PAES JUNIOR, Ademar José de Oliveira. Manual ACM de Terapêutica - Medicina de Família e Comunidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595151956/. Acesso em: 01 jul. 2024.

Bibliografia Complementar

1. PORTO, Celmo Celeno.; Clínica Médica na Prática Diária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738903/. Acesso em: 01 jul. 2024.
2. BARROS, Sônia. Atenção à saúde de populações vulneráveis. São Paulo: Editora Manole, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455265/. Acesso em: 01 jul. 2024.

Outras Referências:

1. BARROS, Sônia. Atenção à saúde de populações vulneráveis. São Paulo: Editora Manole, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455265/. Acesso em: 01 jul. 2024.
2. BEAGLEHOLE, R.; BONITA, R.; KJELLSTRÖM, A. Epidemiologia Básica. Curitiba: Santos, 2017.
3. GAMA, A. S. SUS - Sistema Único de Saúde Esquematizado. Rio de Janeiro: Ferreira, 2017.
4. ZUGNO, P. L. Sociologia da saúde. Caxias do sul: Educs, 2012.

Bibliografia Básica Virtual

1. FERRAZ, C. V. Direito à Diversidade. São Paulo: Atlas, 2015.
2. MATTOS, R. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2007.
3. WALSH, F. Processos normativos da família: diversidade e complexidade. Porto Alegre: Artmed, 2016.
4. McWHINNEY, Ian R; FREEMAN, Thomas R. Manual de Medicina de Família e Comunidade de McWHINNEY. 4 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2017, 536.
5. DUNCAN BB; SCHMIDT MI; GIUGLIANI ERJ; DUNCAN MS; GIUGLIANI C, organizadores.
6. MedicinaAmbulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

8. CRONOGRAMA GERAL - IESCG I – 2026.2

*Cronograma passível de modificações conforme andamento do semestre.

DATA	ATIVIDADE	LOCAL	PROF. RESPONSÁVEIS
03/08	Semana de Integração: Acolhimento, apresentação do plano de ensino, divisão dos grupos (A e B) para os cenários das práticas nas UBS.	**UNIEURO**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita**
10/08	**Tema 1:** História das Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Reforma Sanitária Brasileira.	**UNIEURO**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita**
17/08	**Tema 2:** Princípios e Diretrizes do SUS.	**UNIEURO**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita**
24/08	**Grupo A** (Teoria - **Tema 3**): História da APS no Brasil. Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. **Grupo B** (Prática - **Campo 1**): Reconhecimento da UBS para compreensão do funcionamento do serviço da APS, da Equipe Multidisciplinar, do acolhimento e mapeamento do território.	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
31/08	**Grupo B** (Teoria - **Tema 3**): História da APS no Brasil. Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. **Grupo A** (Prática - **Campo 1**): Reconhecimento da UBS para compreensão do funcionamento do serviço da APS, da Equipe Multidisciplinar, do acolhimento e mapeamento do território.	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
07/09	**FERIADO NACIONAL:** Dia da Independência do Brasil	**- - -**	**- - -**
14/09	**Grupo A** (Teoria - **Tema 4**): Visita Domiciliar, Trabalho dos ACS + Abordagem Familiar e Comunitária. **Grupo B** (Prática - **Campo 2**): Visita domiciliar acompanhado do ACS, Enfermeiro ou Médico.	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
21/09	**Grupo B** (Teoria - **Tema 4**): Visita Domiciliar, Trabalho dos ACS + Abordagem Familiar e Comunitária. **Grupo A** (Prática - **Campo 2**): Visita domiciliar acompanhado do ACS, Enfermeiro ou Médico.	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
28/09	**Grupo A** (Teoria - **Tema 5**): Implicações e políticas públicas no atendimento de populações vulneráveis (campo, florestas, águas, indígena, negra e com deficiência) + Desigualdades Sociais em Saúde **Grupo B** (Prática - **Campo 3**): Alinhamento do PIC (Definição de público-alvo, objetivos e metas).	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
05/10	**Grupo B** (Teoria - **Tema 5**): Implicações e políticas públicas no atendimento de populações vulneráveis (campo, florestas, águas, indígena, negra e com deficiência) + Desigualdades Sociais em Saúde. **Grupo A** (Prática - **Campo 3**): Alinhamento do PIC (Definição de público-alvo, objetivos e metas).	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**

12/10	**FERIADO NACIONAL:** Nossa Senhora Aparecida	**- - -**	**- - -**
19/10	**Grupo A** (Teoria - **Tema 6**): Promoção da Saúde + Educação em Saúde: Continuada, Permanente e Popular. **Grupo B** (Prática - **Campo 4**): Observação do atendimento clínico e do processo de trabalho de profissionais da UBS.	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
26/10	**Grupo B** (Teoria - **Tema 6**): Promoção da Saúde + Educação em Saúde: Continuada, Permanente e Popular. **Grupo A** (Prática - **Campo 4**): Observação do atendimento clínico e do processo de trabalho de profissionais da UBS.	**UNIEURO** **CENÁRIO - UBS**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita** **Preceptor do cenário**
02/11	**FERIADO NACIONAL:** Dia de Finados	**- - -**	**- - -**
09/11	Avaliação Teórica Somativa **(N1):** Aplicação da prova teórica individual referente aos conteúdos ministrados.	**UNIEURO** **(Grupo A e B)**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita**
16/11	Devolutiva **(N1)** – **Tema 7**: Saúde Planetária e Meio Ambiente	**UNIEURO** **(Grupo A e B)**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita**
23/11	Apresentação dos PICs	**CENÁRIO - UBS (Grupo A e B)**	**Preceptor do cenário**
30/11	**FERIADO DISTRITAL:** Dia do Evangélico	**- - -**	**- - -**
07/12	Avaliação Prática **(N2):** Apresentação do Projeto de Intervenção Coletiva (PIC) em sala de aula, entrega dos Portfólios Reflexivos e Fechamento de Notas.	**UNIEURO** **(Grupo A e B)**	**Profª. Andréa Paula e Profª Pedrita**

- O relato de experiência deverá ser anexado na plataforma AVA até o dia 23.11.26.

ANEXO I – ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO COLETIVA

(Metodologia Utilizada – Ensino Baseado em Projetos)

1. Diagnóstico Comunitário

Atividades:

- Territorialização
- Mapeamento social (gestantes, crianças, adultos (doenças crônicas), pessoas idosas…)
- Visitas domiciliares
- Levantamento epidemiológico

Produto: Perfil de saúde da comunidade

- **Fase 1 – Diagnóstico**

Ferramentas ➡ Questionários ➡ Entrevistas ➡ Visitas domiciliares ➡ Dados e-SUS.